Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santiago

Av. Batista Bonotto, 157 - Bairro: Centro - CEP: 97711-500 - Fone: (55) 3029-9981 - 55 9 9932 8498 - Email: frsantiago1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005398-43.2024.8.21.0064/RS

AUTOR: ALINE VIANA BIANCHINI TUSI

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

ALINE VIANA BIANCHINI TUSI, já qualificada, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, também qualificado, alegando, em síntese, ser portador de patologia classificada pelo CID10C50.9 – neoplasia maligna da mama, necessitando fazer tratamento com a medicação Pembrolizumabe 200 mg, todavia, ao solicitar tal medicação junto ao réu teve o pedido negado. Ressaltou que não dispõe de condição financeira para adquirir o fármaco e manter o tratamento. Disse que o réu tem obrigação de fornecer o fármaco postulado e colacionou jurisprudências. Requereu, em sede de tutela antecipada, o imediato fornecimento do medicamento de que necessita. Postulou, ao final, pela procedência da ação, confirmando a liminar. Vindicou a AJG. Juntou documentos (evento 1).

A inicial foi recebida e deferido o benefício da AJG e a tutela antecipada postulada (evento 4).

Citado o IPÊ-SAÚDE apresentou contestação alegando que o medicamento postulado não está previsto no Protocolo Oncológico adotado para o tratamento da enfermidade apresentada. Teceu considerações acerca do sistema de saúde dos servidores públicos e sobre a manutenção de tal sistema. Referiu que o autor pretende um tratamento diferenciado que não será estendido aos demais segurados, o que fere o princípio da isonomia. Postulou pela improcedência da demanda. Acostou documento (evento 21).

Houve réplica (evento 24).

As partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas (evento 26).

Indeferido o pedido de remessa dos autos ao Natjus para parecer, foi encerrada a instrução (evento 33).

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Cuida-se de ação na qual a parte autora objetiva o fornecimento pelo réu do medicamento Pembrolizumabe 200 mg.

Não há preliminares a serem analisadas e, no mérito, procede o pedido da autora.

Consigno que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar as poucas condições financeiras da parte autora em despender, mensalmente, da quantia necessária para compra do medicamento de que necessita (R$ 41.797,86 para cada ciclo - conforme orçamento apresentado no evento 1, OUT7).

Outrossim, restam suficientemente comprovadas a existência da patologia e necessidade dos fármacos, bem como a urgência do uso da medicação pleiteada.

O laudo médico anexado no evento 1, LAUDO3 elenca a grave enfermidade da autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama, classificada sob a CID10C50.9 - carcinoma mamário triplo negativo, estágio III.

Atestou o médico Oncologista clínico, Dr. João Paulo Franco dos Santos (evento 1, LAUDO3):

*"A **paciente acima apresenta o diagnóstico da patologia CID10 C50.9 com carcinoma mamário triplo negativo, estágio III.** Diante disso, a paciente tem indicação de tratamento neoadjuvante com a medicação pembrolizumabe 200 mg via intravenosa, a cada 21 dias, por 12 ciclos, nos moldes do estudo, KEYNOTE-522. Este estudo demonstrou maior taxa de resposta (redução tumoral) menor risco de recidiva de doença (surgimento de metástases) quando o pembrolizumabe é adicionado ao tratamento. O uso pembrolizumabe para esta indicação está de acordo com a bula do medicamento, a qual foi aprovada pela ANVISA (...)*

*A Paciente necessita da medicação em caráter de urgência. **O não uso da medicação pode significar aumento do risco de recaída, com diminuição da chance de cura e aumento do risco de morte**."* (suprimi e grifei)

Não pode ser afastada a credibilidade da prescrição efetuada pelo profissional que acompanha o tratamento do demandante, por possuir melhor condição de avaliar o seu estado de saúde e a prescrição recomendada.

Demonstrada, portanto, a necessidade e o cabimento do remédio postulado para o tratamento da grave doença que acomete o autor.

Quanto ao fornecimento, ressalto que o pedido da inicial não se alicerça na responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, disposta no art. 196 da Constituição Federal, mas na responsabilidade do Plano de Saúde, assim necessário observar as normativas que regulamentam o plano.

Consigno que, em 06 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, revogando, portanto, a Lei Complementar nº 12.134/04.

Desta feita, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu após a entrada em vigor da LC 15.145/2018, esta é a legislação aplicável ao caso.

Tal legislação dispõe sobre o IPE-Saúde e refere que o plano de saúde integra atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, *in verbis*:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial,* ***bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários,*** *na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

O parágrafo primeiro do artigo acima refere que os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do IPERGS restam excluídos da cobertura do plano de saúde e o parágrafo segundo exige a aprovação do Órgão Gestor para inclusão de novos procedimentos, *in verbis*:

> *§ 1º* ***Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde*** *os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais,* ***que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.***
>
> *§ 2º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial*

Todavia, em que pesem as disposições da nova lei, entendo que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.

Ressalto que, as Recomendações Técnicas em Oncologia do próprio Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul não possuem a pretensão de ser completas ou definitivas e não apresentam caráter excludente, prevendo a possibilidade de exame de casos excepcionais, bem como a não intervenção na autonomia do médico assistente, assim entendo que descabe negar acesso do segurado a tratamento médico.

Cabe destacar, ainda, que a Resolução nº 21/1979, que regulamenta a assistência Médico-Hospitalar do IPERGS, assim dispõe:

> *Artº 2º - O plano de Assistência Médica destinado aos associados e seus dependentes coibirá os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento.*
>
> *§ Primeiro – O Plano será restrito aos princípios da Medicina Curativa sendo, no entanto, admissível em casos especiais a instituição de procedimentos preventivos.*
>
> *§ Segundo – O Plano será fundamental baseado nos seguintes princípios:*
>
> *a) co-participação financeira do usuário.*
>
> *b) livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas.*
>
> *Artº 8º - Incluem-se no Plano de Assistência Médica, em consonância com as respectivas normas, as seguintes especialidades:*
>
> *Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geral, Ginecologia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia (Alergia), Medicina Nuclear, Nefrologia, Obstetrícia, Oftalmologia,* ***Oncologia,*** *Otorrinolaringologia, Patologia Clínica e Cirurgia, Pediatria, Plástica reparadora, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Tisiopneomologia, Torácica, Traumatologia e Urologia.*
>
> *(...)*
>
> *Artº 9º - A assistência médico-hospitalar abrangerá os seguintes serviços:*
>
> *1 – Emergências*
>
> *2 – Consultas Médicas*
>
> *3 – Serviços Complementares*
>
> *4 – Tratamento Ambulatorial*
>
> *5 – Tratamento Hospitalar*

Oportuno mencionar que a patologia que acomete a demandante – qual seja, neoplasia de mama encontra-se arrolada na página 32 das Recomendações Técnicas[1].

Em que pese o §1º do art. 4º da Lei Complementar n. 15.145/18, disponha que estão excluídos da cobertura os tratamentos que não estejam previstos nas tabelas do próprio instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é cristalino quanto à impossibilidade de o plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado.

Nesse sentido, destaco precedentes da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)."

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)."

É neste mesmo compasso que converge a jurisprudência do Tribunal de Justiça Gaúcho:

"APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ECA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTIPEDIÁTRICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE OSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. ***A responsabilidade pelo atendimento à saúde (no caso, transferência do paciente para hospital com UTI Pediátrica) é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública.*** *2. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. 3. Não há falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração. [...]. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA, NOS DEMAIS PONTOS, EM REEXAME NECESSÁRIO.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081082984, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-05-2019)" grifei*

"REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. METÁSTASE ÓSSEA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. TRASTUZUMABE COM ENTANSINA (TDM1). ***O segurado do IPE-SAÚDE tem direito ao recebimento de medicamento indispensável ao tratamento de sua grave moléstia, uma vez que a especialidade oncologia está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do IPE-SAÚDE, do medicamento indicado não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, credenciado pela Autarquia, que o teve como sendo o adequado e necessário para o tratamento da moléstia que acomete a parte,*** *NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA, com metástase óssea. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70085426260, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 27-10-2021)" grifei*

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. DEVER DE FORNECIMENTO PELO IPE-SAÚDE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO IPERGS AO FADEP. DESCABIMENTO. 1. Caso em que a parte autora requer o fornecimento do medicamento Ibrutinibe, pois é segurada do IPE-Saúde e portadora de ***Linfocítica Crônica*** *(Leucemia). 2.* ***O IPERGS tem o dever de fornecer o tratamento postulado, não excluído do Plano de Saúde, e devidamente indicado por médico competente ao paciente. A ausência de previsão de medicamento em listas do réu não impede a determinação de fornecimento do tratamento necessário à saúde da parte apelada.*** *Inteligência das Leis nº 7.672/82, LC nº 12.134/2004, art. 196 da CF, e 241 da CE. Precedentes jurisprudenciais. 3. Comprovada a necessidade do tratamento médico prescrito pelo médico da requerente e a impossibilidade de aquisição deste, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao fornecimento da medicação. 4. Afastada a condenação do IPERGS ao pagamento de honorários em favor do FADEP uma vez que há confusão entre credor e devedor. Representativo de controvérsia repetitiva julgado pelo STJ e Precedentes Jurisprudenciais da Corte. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082864596, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 17-12-2019)" grifei*

Desta feita, entendo que o plano de saúde deve fornecer o tratamento de oncologia postulado, pois comprovada a enfermidade que acomete o autor e a necessidade da medicação.

Por fim, nas ações de medicamentos deixo de fixar os honorários contra a Fazenda Pública constantes do art. 85 § 3º 4º e 5º do CPC, pois tal fixação oneraria demasiadamente os entes públicos em decorrência de ações que são simples e repetitivas e que não exigem trabalho excessivo do (a) procurador (a).

Consigno, ainda, que a fixação dos honorários nos termos do art. 85 § 4º, inc. III do CPC acarretaria prejuízo à Fazenda Pública, pois o valor da causa nas ações de medicamentos, na maioria das vezes, é arbitrada pelo valor dos fármacos, o que acarreta honorários significativos em caso de medicamentos de custo elevado.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por **ALINE VIANA BIANCHINI TUSI,** já qualificada, para **CONDENAR o IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS** ao fornecimento da medicação necessitada pela autora, qual seja: **Pembrolizumabe 200mg,** na dosagem indicada na inicial, enquanto durar o tratamento.

Determino que a autora apresente, a cada seis meses, laudo médico que demonstre a necessidade de se manter o fornecimento do medicamento.

Confirmo a decisão antecipatória da tutela, evento 04.

Condeno o IPERGS no pagamento de honorários advocatícios aos procuradores do autor, que, na forma do art. 85, §8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), que, em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

O réu é isento do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014), não foram antecipadas custas pela parte autora nem houve despesas com Oficial de Justiça para reembolso.

Publicação e intimação automáticas.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **VALERIANO SANTOS FILHO, Juiz de Direito**, em 07/08/2025, às 16:08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10086454888v4** e o código CRC **855b722e**.

---

1. Disponível em: http://ipesaude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202001/22153315-rt-oncologia-20jan2020.pdf ↩